EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 92486
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-10 11:46:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUIS MIGO SALAZAR			RUN	: 9.712.487-6
F.Nac	: 19-06-1962	Edad	: 62 AÑOS, 2 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: INDEPENDENCIA 6471			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-08-19	Fecha Egreso	: 2024-09-10 11:46:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. K66.9-TRASTORNO DEL PERITONEO, NO EPSECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

TRAUMA ABDOMINAL CERRADO CON PERFORACION INTESTINAL
COLECCION ABDOMINAL
INFECCION DE HERIDA OPERATORIA
CRISIS HIPERTENSIVA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K63.1-PERFORACION DEL INTESTINO (NO TRAUMATICA) (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. N17-INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. R57.2-CHOQUE SEPTICO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. K65-PERITONITIS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. D50.9-ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN OTRA ESPECIFICACION (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE REFIERE CAIDA A NIVEL EN BICILETA EL 18/8/24, INGRESADO POR URGENCIAS 19/8/24 POR TRAUMA ABDOMINAL CERRADO CON PERFORACION INTESTINAL INGRESA EN MALAS CONDICIONES CON REQUERIMEINTOS DE DVA. EL 19/8/24 SE REALIZA LAPAROTOMIA EXPLORADORA SE REALIZA RAFIA INTESTINAL Y SE DEJA DRENAJE. POSTOPERADO EN UCI Y POSTERIORMENTE EN UTO CON PARAMETROS INFLAMATORIOS PERSISTENTEMENTE ALTOS A PESAR DE TTO ANTIBIOTICO CON MEROPENEM. POR LO CUAL SE REALIZA TAC AP C/C QUE EVIDENCIA COLECION PERIHEPATICA DE 35 X 16 MM. SE PLANTEA RELAPAROTOMIA EL 1/9/24 EN LA CUAL SE DRENA COLECCION SE REALIZA ASEO QUIRURGICO Y SE DEJAN 2 DRENAJES. POSTOPERADO EN UCI CON BUENA EVOLUCION Y ES TRALADADO A SALA COMUN EL 6/9/24 ACTUALMENTE EN BUENAS CONDICIONES TOLERA REGIMEN LIVIANO, AYER CRISIS HIPERTENSIVA ASINTOMATICA QUE CEDE A CAPTOPRIL SUBLINGUAL. CON EXUDADO SEROSO POR HERIDA OPERATORIA Y PEQUEÑA ZONA PERIUMBILICAL CON ESFACELOS. SE RETIAN GRAPAS Y SE DECIDE CONTINUAR MANEJO POR HODOM.

PLAN DE MANEJO:

ALTA POR HODOM

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO
2. FAJA ABDOMINAL DIURNA POR 2 MESES
3. REGIMEN LIVIANO HIPOSODICO
4. LOSARTAN 50 MG C/12 HRS VO
5. CEFADROXILO 500 MG C/8 HRS POR 7 DIAS

6. OMEPRAZOL 20 MG AL DIA EN AYUNAS POR 10 DIAS
7. PARACETAMOL 1 GR C/8 HRS POR 3 DIAS
8. CURACIONES DIAS POR MEDIO PÓR HODOM
9. CONTROL EN CESFAM PARA CONTROL PRESION ARTERIAL
10. CONTROL EN URGENCIAS SOS

Control en: 21 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

SOFÍA MACARENA SPANO TORRES
MEDICO TRATANTE
17043328-9

JEFE SERVICIO